Atención humanizada y habilidades centradas en la persona

Breve descripción:

Este componente formativo integra el desarrollo de habilidades del talento humano en salud con la humanización de la atención, fortaleciendo relaciones interpersonales y promoviendo modelos centrados en la persona. Desde el reconocimiento de fortalezas y áreas de mejora, se fomenta una atención integral, participativa y orientada al bienestar, la dignidad humana y el rol activo de pacientes, familias y comunidades.

Febrero 2026

Tabla de contenido

Introducción 3

1. Habilidades propias aplicadas en la atención humanizada 6

1.1. Trabajo en equipo 6

1.2. Liderazgo 14

1.3. Empatía 17

2. Atención humanizada 20

2.1. Sentido de vida 20

2.2. Relación interpersonal (personal de la salud – persona y su red de apoyo – organización) 23

3. Gestión centrada en la persona 26

3.1. Antecedentes del modelo de atención centrada en la persona 26

3.2. Modelo de atención centrada en la persona 32

3.3. Experiencias den Colombia 39

Síntesis 53

Glosario 54

Referencias bibliográficas 56

Créditos 58

Introducción

En este componente formativo se abordará el fortalecimiento de las habilidades propias del talento humano en salud como base para una atención humanizada, reconociendo su impacto en la calidad del cuidado y en las relaciones que se establecen entre el personal de salud, las personas, sus familias o redes de apoyo, así como las organizaciones. Se profundizará en competencias como el trabajo en equipo, el liderazgo y la empatía, entendidas como elementos clave para promover interacciones respetuosas, colaborativas y orientadas al bienestar integral.

Asimismo, se analizará la atención humanizada desde una perspectiva centrada en la persona, incorporando el sentido de vida y la relación interpersonal como ejes que dignifican el cuidado en salud. Este enfoque permitirá comprender la evolución y los fundamentos del modelo de atención centrada en la persona, así como su aplicación en el contexto colombiano, destacando experiencias que promueven la participación activa de individuos, familias y comunidades.

Partiendo de lo anterior, se invita a que acceda al siguiente video, el cual relaciona la temática a tratar durante este componente formativo:

Video 1. Atención humanizada y habilidades centradas en la persona

Enlace de reproducción del video

Síntesis del video: Atención humanizada y habilidades centradas en la persona
La atención en salud se construye a partir de los encuentros cotidianos entre personas, donde las acciones, actitudes y decisiones del talento humano influyen directamente en la experiencia del cuidado. En este contexto, desarrollar habilidades humanas es esencial para brindar una atención que reconozca la dignidad, las emociones y las necesidades de quienes participan en el proceso de atención. A lo largo de este componente se abordarán habilidades como el trabajo en equipo, el liderazgo y la empatía, entendidas como competencias que fortalecen la coordinación, el respeto mutuo y la capacidad de respuesta ante situaciones complejas. Estas habilidades favorecen relaciones más colaborativas entre el personal de salud y contribuyen a un ambiente de atención más seguro y consciente.

Asimismo, se profundiza en la atención humanizada como un enfoque que valora el sentido de vida de cada persona y reconoce la importancia de la relación interpersonal entre el personal de salud, la persona atendida, su familia o red de apoyo y la organización. Desde esta perspectiva, la atención trasciende el acto técnico y se convierte en un proceso basado en la escucha, el respeto y la corresponsabilidad.

Finalmente, se introduce la gestión centrada en la persona como un modelo que articula estas habilidades y principios en la planificación y prestación de los servicios de salud. A partir de sus antecedentes, su desarrollo conceptual y las experiencias en Colombia, se evidencia como este enfoque promueve la participación activa, orienta las decisiones y fortalece una atención integral, ética y comprometida con la humanización de la salud.

1. Habilidades propias aplicadas en la atención humanizada

Estas habilidades hacen referencia a las capacidades personales y sociales que el talento humano en salud emplea para brindar una atención centrada en la persona. Además, permiten reconocer a pacientes, familias y redes de apoyo como sujetos activos, con dimensiones emocionales, sociales y culturales que influyen en el proceso de atención.

Entre las habilidades más relevantes se encuentran el trabajo en equipo, el liderazgo y la empatía, las cuales favorecen relaciones respetuosas, cooperación interdisciplinaria y toma de decisiones orientadas al bienestar. Su adecuada aplicación contribuye a generar confianza, mejorar la experiencia del usuario y fortalecer la calidad del servicio.

Aunque tienen una base individual, estas habilidades pueden desarrollarse y fortalecerse, mediante la reflexión sobre la práctica, el autoconocimiento y el aprendizaje colectivo. Su integración en la atención en salud promueve respuestas éticas y humanizadas, orientadas a la dignidad y a las necesidades reales de las personas.

1.1. Trabajo en equipo

Para comprender la importancia del trabajo en equipo en la vida humana y en la atención en salud, se invita a acceder al siguiente pódcast, un espacio de reflexión que aborda esta habilidad como un pilar fundamental de la humanización. A lo largo de este contenido, se analiza cómo el trabajo en equipo permite la construcción del bien común, desde las interacciones cotidianas hasta los escenarios organizacionales más complejos. Asimismo, se reflexiona sobre su presencia constante en la vida en sociedad

y su impacto en la calidad de la atención en salud, destacando la articulación de personas, roles y procesos como un sistema interdependiente orientado al cuidado, el bienestar y la dignidad humana:

Síntesis del Podcast: Trabajo en equipo
A continuación, se presenta un pódcast que aborda el trabajo en equipo como una habilidad esencial del ser humano y un componente clave de la humanización en la atención en salud, destacando su presencia en la vida cotidiana y su importancia en la articulación de personas, roles y procesos orientados al bienestar común.
Este pódcast invita a comprender el trabajo en equipo como una dinámica esencial de la vida en sociedad, resaltando cómo la coordinación, la colaboración y la interdependencia influyen en las acciones cotidianas y en la atención en salud. Este espacio abre el diálogo para reconocer el aporte de cada persona en la construcción de objetivos comunes y del bienestar colectivo. Hablar de trabajo en equipo es entenderlo como una característica de la humanización en la atención en salud, pues a través de este, se logra conseguir el bien común. La habilidad del trabajo en equipo se define como la capacidad de organizar y coordinar a las personas para cumplir una misión común y alcanzar objetivos compartidos. Es importante comprender que el trabajo en equipo forma parte de la vida cotidiana del ser humano, ya que al vivir en sociedad se interactúa de manera constante en distintos grupos. En muchos casos, esta dinámica pasa desapercibida,

pues no se limita únicamente a los entornos laborales, sino que está presente en múltiples escenarios de la vida diaria.

Por ejemplo, la compra de un artículo para el hogar, vestimenta o alimentos suele percibirse como una acción individual; sin embargo, para que un producto esté disponible en el punto de venta intervienen múltiples procesos de diseño, producción, distribución y comercialización, resultado del esfuerzo articulado de diversas personas que operan como un sistema. Este conjunto de acciones evidencia un trabajo en equipo implícito, indispensable para satisfacer una necesidad cotidiana.

De manera similar sucede en las organizaciones de salud, el trabajo en equipo se manifiesta en la interacción coordinada de todos los actores que participan en la atención. Desde el personal de seguridad que facilita el ingreso, pasando por el talento humano asistencial y administrativo, hasta las directivas institucionales, sin excluir a las personas usuarias y sus familias, todos conforman un sistema interdependiente orientado al cuidado y bienestar.

Se invita al oyente a trasladar lo abordado a su práctica cotidiana, reconociendo la importancia del trabajo en equipo en sus acciones y relaciones. Asimismo, se propone aplicar estos aprendizajes en contextos reales, fortaleciendo la colaboración, el compromiso compartido y la construcción del bienestar común.

- **Virtudes en el trabajo de equipo**

  El IIPE (Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación, 2000) determina algunas características de los equipos de alto desempeño:

- Tener claridad en la misión y visión institucional.
- Organización del trabajo.
- Conciencia de lo medular que resulta para una organización cuidar al máximo las reuniones de trabajo.
- Capacidad institucional para enfrentar las dificultades y convertirlos en oportunidades.
- Valor por la experiencia y la creatividad del personal de salud.
- Fortalecimiento en la organización en aumentar su capacidad de comunicación y el liderazgo en su personal.
- Promocionar altos grados de autonomía y responsabilidad en el personal de salud.
- Establecimiento de altos estándares de calidad de los servicios, la planeación, los procesos y resultados.
- Generación de estrategias de monitoreo y seguimiento de los objetivos formulados.
- Establecer criterios de evaluación del desempeño individual y grupal en conocimiento de todos.
- La autonomía de los equipos de trabajo en la posibilidad de participar en diferentes proyectos.
- Fomentar la conciencia de la importancia de la formación y la capacitación continua, del conocimiento compartido, del apoyo de carácter reflexivo, de incentivar el profesionalismo y responsabilidad.
- Asignación de presupuesto en generar lineamientos y políticas en favor del recurso humano y de formación.

Se reconoce el beneficio en que se favorece, no solo para la organización, sino para el equipo, ya que genera un ambiente de confianza, respeto y colaboración apropiado en cada ámbito, bien sea laboral o personal. Un equipo funciona sobre la base objetiva de oferta y demanda de servicios y de una base subjetiva como es: la interdependencia y confianza entre sus miembros del equipo de trabajo.

Trabajo en equipo

El video, que se encuentra en el siguiente Link https://www.youtube.com/watch?v=3n1gHAbsGfg relaciona las características del trabajo en equipo mencionadas, aplicándolas de una manera muy específica y representativa.

- **Principios básicos del trabajo en equipo para aplicar en atención en salud**

"Los buenos profesionales hacen buenos equipos, pero también buenos equipos hacen buenos profesionales, lo cual supone un enriquecimiento social" (Borrell-Carrió, 2004). A continuación, se presentan algunos principios básicos para aplicar en la atención en salud:

- **Comunicación**

  La comunicación como base de los equipos de trabajo.
- **Liderazgo**

  Fomenta el liderazgo de sus participantes.
- **Objetivos**

  El equipo debe conocer y aceptar los objetivos.
- **Responsabilidad**

Todo integrante del equipo debe tener claro, cuál es su responsabilidad y el trabajo que le fue asignado.

- **Cooperación**

  Todos los integrantes del equipo deben cooperar de manera activa y solidaria.

- **Comunicación interna**

  Un equipo debe tener buena comunicación interna.

- **Conocimiento mutuo**

  Los miembros de los equipos deben conocer las actividades que desarrollan cada uno de ellos.

- **Valoración**

  Brindar estímulos en el equipo, no dedicarse a castigar las debilidades

- **Motivación**

Un factor importante en crear un ambiente favorable de trabajo en equipo y el logro de los objetivos en la atención en salud humanizada, es la motivación, la cual juega un papel importante, entendiéndola como una fuerza direccionada al logro de un propósito, que, al ser alcanzado, habrá de generar satisfacción. La motivación tiene que ver con el optimismo, el cual es una capacidad de seguir adelante y de continuar persiguiendo los objetivos a pesar de las adversidades.

La motivación puede ser generada por los procesos mentales individuales (automotivación) o provenir del entorno (estímulo externo). Ambos procesos se destacan por:

- **Automotivación**

Se caracteriza por realizar una acción con el fin de tener satisfacción percibida en el momento. Las personas con automotivación, tienden a ser más organizadas, más proactivas y tener habilidades de gestión, tienden a una mejor autoestima y confianza. Estas capacidades influyen en tomar diferentes riesgos, en contemplar la mejora continua, en realizar esfuerzos adicionales para lograr los objetivos, en buscar oportunidades continuamente, en querer lidiar con los reveses y continuar persistiendo a conseguir la meta a pesar de los obstáculos.

- **Estímulo externo**

Se caracteriza por realizar una acción con el fin de obtener algún tipo de recompensa. Las personas que responden al estímulo externo orientan su conducta a partir de incentivos ofrecidos por el entorno, como reconocimientos, recompensas económicas, ascensos o retroalimentación positiva. Estos estímulos favorecen el cumplimiento de metas, refuerzan comportamientos deseados y aumentan el compromiso con las tareas asignadas. Asimismo, puede promover la constancia, la mejora del desempeño y la adherencia a normas y objetivos institucionales.

A continuación, se explica todo el proceso que tiene que ver con la motivación y las diversas acciones en donde está presente:

- **Motivación**

"Una fuerza direccionada al logro de un propósito, que, al ser alcanzado, habrá de generar estímulos de satisfacción"

- **Automotivación**

Se caracteriza por realizar una acción con el fin de tener satisfacción percibida en el momento. Los motivadores intrínsecos incluyen el amor, divertirse, estar interesado y desafiarse personalmente.

- **Optimismo**

La motivación tiene que ver con el optimismo, el cual es una capacidad de seguir adelante y de continuar persiguiendo los objetivos a pesar de las adversidades.

- **Metas**

Lograr el éxito en una organización, con equipos de trabajo comprometidos, puede ser sinónimo de una mayor productividad y logros alcanzados. Cuando se tiene en cuenta la motivación del talento humano.

- **Rendimiento**

El rendimiento y la calidad del trabajo precisa una dependencia en la satisfacción laboral de cada persona.

- **Logros**

El resultado satisfactorio o logro son estímulos que pueden provenir del entorno (estímulo externo) o puede ser generado por los procesos mentales individuales (automotivación), que incentivan alcanzar las metas propuestas, sean personales o laborales.

- **Reconocimiento**

Se caracteriza por realizar una acción con el fin de obtener algún tipo de recompensa.

Lograr el éxito en una organización con equipos de trabajo comprometidos se traduce en mayor productividad y resultados alcanzados. Sin embargo, el rendimiento y la calidad del trabajo dependen directamente de la satisfacción laboral de cada persona. Por consiguiente, comprender los factores de motivación facilita la creación de un ambiente donde la automotivación pueda florecer.

Es importante tener presente que la motivación es fundamental en las personas líderes, ya que tienden a inspirar a los demás con sus acciones. Los líderes efectivos no actúan solos, sino a través de su equipo. Por este motivo, entender las motivaciones de quienes trabajan con ellos es una competencia clave para dirigir de manera eficaz.

1.2. Liderazgo

El trabajo en equipo en salud tiene como uno de sus principios el liderazgo, el reconocimiento de la importancia en las acciones que realiza la otra persona, sin importar la profesión o la escala jerárquica, pues el fin es el bien común. Según Bryman (1996) citado por Toro (2015, pp. 11-12): “el liderazgo transformacional presenta una connotación orientada a la participación y flexibilidad de los procesos de la organización”.

Por lo anterior, los líderes se caracterizan por:

- Transmitir entusiasmo y motivación a su equipo.

- Enfocarse en conseguir los objetivos organizacionales.
- Incentivar la creatividad, la innovación en las funciones, acciones y medidas.
- Generar un valor agregado a sus resultados, individuales o grupales.
- Tener variedad de conocimiento experiencial.
- Generar confianza en su equipo.

- **Aprendiendo a ser un líder**

Chopra (2005) citado por Toro (2015, pp. 13-14) afirma que: “se aprende a ser un líder siendo catalizador del cambio y de transformación. Los grandes líderes responden con creatividad, visión y sentido de la unidad, sin importar la magnitud del problema. La inspiración y la unidad del grupo se logran al comprender las jerarquías de necesidades”.

Por consiguiente y tomando como referencia al autor, se deben tener en cuenta las siguientes acciones para tener un buen liderazgo:

- **Mirar y escuchar con todos los sentidos**

Sin juzgar, usa el corazón, obedece a los sentimientos y al alma. Respondiendo con visión y creatividad.

- **Delegar**

Esto procede del autogobierno. Es un proceso orientado que eleva al mismo nivel al líder y sus seguidores.

- **Concienciar**

Conoce las preguntas que hay detrás de cada reto: ¿Quién es? ¿Qué se quiere? ¿Cuál es el objetivo vital? El líder debe plantearse estas cuestiones e inspirar a sus seguidores para que se las planteen ellos mismos.

- **Actuar**

Es responsable de las promesas que se hace, es persistente, pero también capaz de celebrar y ver cualquier situación con flexibilidad y humor.

- **Ser libre emocionalmente**

El líder está por encima del melodrama, libre de la toxicidad emocional para comprender las necesidades de los demás sin miedo, sin depresión y sin los nocivos residuos de la competitividad.

- **Ser responsable**

Demuestra iniciativa, asume los retos maduros, no los inútiles, teniendo integridad y viviendo de acuerdo con los valores.

- **Sincronía**

Ingrediente misterioso de la inconsciencia que todos los grandes líderes tienen. Es la capacidad de crear la buena suerte y encontrar las reservas de poder, que llevan a un líder más allá de los resultados previstos. Es la capacidad de conectar una necesidad con una respuesta del alma.

1.3. Empatía

Para conocer de manera directa lo que trata la empatía, es preciso ingresar al siguiente video, el cual explica sobre esta capacidad humana y contextualiza al respecto:

Video 2. Empatía

Enlace de reproducción del video

Síntesis del video: Empatía
Y considera la empatía como una habilidad social desarrollada, como la capacidad de reconocer sentimientos, necesidades, realidades e intereses de los demás. Autores como Aidé Martínez, en su artículo hacia una comunicación efectiva y humanista en ámbitos de salud, reconoce la empatía como elemento fundamental en las relaciones interpersonales en la cotidianidad de los sistemas de salud. Vamos a

explicarlo mejor. Según Goldman, la empatía se compone de las siguientes aptitudes, comprender a los demás.

Ayudar a los demás a desarrollarse, orientación hacia el servicio, aprovechar la diversidad, conciencia política. Entonces el proceso interno es el proceso que hace la persona antes de la acción, es decir, en los casos mencionados.

Usted debe percibir los sentimientos ajenos e interesarse activamente por las preocupaciones. Para comprender a los demás. Usted debe percibir las necesidades de desarrollo de los demás y fomentar sus capacidades para ayudar a los demás a desarrollarse. Usted debe prever y reconocer las necesidades de las personas para poder llegar a satisfacerlas o establecer que tiene orientación hacia el servicio.

Reconocer la diferencia como oportunidad es aprovechar la diversidad e interpretar las corrientes sociales y políticas es generar consciencia política.

Cuando se habla de relaciones interpersonales, encontramos que el desarrollo adecuado de las mismas no tiene una estrategia única de abordaje, por el contrario, son múltiples. Sin embargo, es fundamental entender que abordar empáticamente alguna situación o relación es un proceso de interés de las partes involucradas.

Goleman (1995) considera la empatía como una habilidad social, desarrollada como la capacidad de reconocer sentimientos, necesidades, realidades e intereses de los demás. Autores como Haydé Martinez en su artículo “Hacia una comunicación efectiva y humanista en ámbitos de salud” reconoce la empatía como elemento fundamental en las relaciones interpersonales en la cotidianidad de los sistemas de salud.

En síntesis, la empatía trasciende la comprensión emocional para convertirse en una práctica consciente que orienta la forma de relacionarse con los demás. Reconocer sentimientos, necesidades y contextos permite fortalecer la comunicación, generar confianza y favorecer interacciones respetuosas y humanizadas. En los escenarios de salud, la empatía se consolida como una habilidad esencial que contribuye a una atención centrada en la persona, promoviendo vínculos más éticos, sensibles y comprometidos con la dignidad humana.

2. Atención humanizada

En el ámbito de la salud, la atención humanizada constituye un enfoque esencial para garantizar un cuidado integral, seguro y de calidad. Reconoce que la práctica sanitaria no se limita a la aplicación de conocimientos técnicos o clínicos, sino que involucra habilidades personales y sociales como el trabajo en equipo, el liderazgo y la empatía, fundamentales para establecer relaciones terapéuticas efectivas. La atención humanizada sitúa a la persona como eje del proceso de cuidado, considerando su dignidad, emociones, contexto social y red de apoyo. En este marco, el sentido de vida del personal de la salud cobra relevancia, ya que orienta su vocación, fortalece el compromiso ético y favorece interacciones respetuosas y conscientes con las personas atendidas y con la organización, sentando las bases para una gestión y un modelo de atención centrados en la persona.

2.1. Sentido de vida

Las relaciones personales, el autorreconocimiento y las aptitudes individuales se encuentran estrechamente vinculadas con la forma en que las personas interactúan en los diferentes contextos de la vida, especialmente en el ámbito de la atención en salud. La manera en que cada individuo se comprende a sí mismo influye directamente en la calidad de sus relaciones y en la forma como se relaciona con los demás.

El autoconocimiento, entendido como una herramienta para gestionar metas personales e institucionales, está estrechamente ligado al sentido a la vida que cada persona construye. Este corresponde al propósito que cada ser humano define para su existencia y es plenamente armonizable con la vocación, el carisma del quehacer y la disciplina que el personal de la salud desempeña en su práctica cotidiana. Reconocer, definir y comprender el propio propósito de vida potencia la capacidad de identificarse

con los objetivos, metas y sueños personales, y facilita, a su vez, el reconocimiento de los demás desde criterios de respeto y comprensión.

Cuando el sentido a la vida se alinea con el rol o la labor desempeñada diariamente, aumenta la posibilidad de establecer metas comunes, trabajar por el bienestar propio y colectivo, y generar impactos positivos y significativos. En el ámbito de la atención en salud, este aspecto cobra especial relevancia, ya que el bienestar del personal se traduce directamente en el bienestar de las personas atendidas, dada la naturaleza de una labor orientada al servicio y al cuidado de la vida. Por ello, el respeto y la dignidad humana deben constituirse en pilares fundamentales del proyecto de vida personal, profesional y familiar del personal de la salud.

El sentido a la vida encuentra su fundamento en la necesidad que tiene cada persona de otorgar significado a su propia existencia. No es la vida la que proporciona ese significado de manera automática, sino que cada individuo enfrenta el desafío de construirlo a partir de sus decisiones, acciones y experiencias.

Las decisiones y acciones que se adoptan a lo largo de la vida configuran y revelan el sentido que se le otorga a la existencia. La vida interpela, cuestiona y desafía constantemente a las personas, invitándolas a responder de manera consciente y responsable.

Finalmente, el sentido que se atribuye a las acciones y a los planes personales permite orientar la comprensión de la razón de existir y del propósito de vida. Este proceso forma parte esencial del crecimiento personal y profesional, especialmente en quienes desempeñan labores de cuidado, y constituye un elemento clave para fortalecer una atención en salud verdaderamente humanizada.

Con base en lo anterior, el sentido a la vida orienta acciones y procesos personales y profesionales que fortalecen la atención humanizada en salud, como son:

- **Autoconocimiento**

Hace referencia a la capacidad de reconocer las propias emociones, valores, fortalezas, limitaciones y motivaciones. En el personal de la salud, este proceso permite actuar de manera consciente, regular las emociones en situaciones complejas y alinear el ejercicio profesional con principios éticos y humanos.

- **Propósito de vida**

Corresponde a la razón que orienta las decisiones y proyectos personales y profesionales. En la atención en salud, este propósito se vincula estrechamente con la vocación de servicio y el compromiso con el cuidado de la vida, favoreciendo prácticas responsables, empáticas y centradas en la persona.

- **Vocación de servicio**

Se entiende como la disposición interna para atender y cuidar a otros con responsabilidad, respeto y sensibilidad. En el contexto sanitario, esta vocación fortalece la atención humanizada, promoviendo relaciones basadas en la dignidad humana y el reconocimiento del otro como un ser integral.

- **Valores personales y éticos**

Orientan la conducta y la toma de decisiones en la vida cotidiana y profesional. En el ámbito de la salud, valores como el respeto, la solidaridad, la responsabilidad y la empatía son fundamentales para garantizar una atención segura, justa y humanizada.

- **Bienestar personal**

Comprende el equilibrio físico, emocional, social y espiritual de cada individuo. Para el personal de la salud, cuidar el propio bienestar es una condición necesaria para ofrecer una atención de calidad, ya que el autocuidado impacta directamente en la relación con las personas atendidas y en el trabajo en equipo.

- **Proyecto de vida**

Integra las metas, sueños y aspiraciones personales y profesionales. En el campo de la salud, este proyecto se construye de manera articulada con el sentido a la vida, permitiendo orientar el crecimiento personal, el desarrollo profesional y la contribución al bienestar colectivo.

2.2. Relación interpersonal (personal de la salud – persona y su red de apoyo – organización)

Desde el enfoque de la humanización, se reconoce la importancia de las relaciones interpersonales, las cuales se establecen entre personas o grupos de personas. Estas relaciones permiten el intercambio de información, la comunicación efectiva, la expresión de emociones, la toma de decisiones compartidas y la puesta en práctica de acciones orientadas a ayudar y servir a otros, lo cual constituye el quehacer cotidiano de la atención humanizada en salud.

La interacción interpersonal entre el talento humano en salud, la persona sujeto de cuidado, su red de apoyo y la organización, se convierte en un elemento esencial para brindar una atención humanizada, basada en el respeto, la empatía y la dignidad humana.

Para establecer relaciones interpersonales asertivas, se pueden identificar 3 aspectos principales:

- **Objetividad:** es la capacidad de salirse de sí mismo y alcanzar puntos en común con la otra persona.
- **Respeto:** es el reconocimiento del otro.
- **Tolerancia:** es la capacidad de entender pensamientos y acciones estando en desacuerdo.

Asimismo, se pueden considerar las siguientes aptitudes que favorecen las relaciones interpersonales entre el paciente y familia, el personal de salud y las organizaciones:

- **Confianza:** en muchos encuentros iniciales pueden surgir dudas o desconfianza; esta aptitud promueve la disposición a creer en el otro, facilitando relaciones basadas en la seguridad, el respeto y la apertura.
- **Aceptación:** implica la capacidad de escuchar activamente y reconocer el conocimiento, la experiencia y la experticia de la otra persona, valorando su aporte en la interacción.
- **Igualdad:** permite comprender que, más allá de las diferencias étnicas, etarias, culturales, religiosas o socioeconómicas, todas las personas deben ser reconocidas desde su dignidad, favoreciendo escenarios de diálogo respetuoso.
- **Empatía:** es una aptitud transversal al comportamiento humano que posibilita comprender la realidad del otro, considerando sus emociones y experiencias, lo que fortalece la relación interpersonal y genera satisfacción mutua.

- **Espontaneidad:** la autenticidad y la naturalidad son esenciales en las relaciones interpersonales; esta aptitud permite actuar con agrado y coherencia, respetando la autonomía y la libertad del otro.
- **Flexibilidad:** refleja la capacidad de adaptación y tolerancia en el trato interpersonal, facilitando la convivencia en diversos entornos y promoviendo la apertura al diálogo, la concertación y el reconocimiento de distintas formas de pensar.

Estas aptitudes posibilitan el desarrollo de una actitud de humanización, la cual permite confrontar las dificultades que se pueden presentar en las relaciones interpersonales (por ejemplo, el conflicto) y convertirlas en oportunidades de aprendizaje, manteniendo la capacidad de apoyo y servicio.

Humanización en salud Covid-19

Para complementar las habilidades para la atención humanizada, se recomienda revisar esta charla la cual se titula: humanización de los servicios de salud en tiempos de Covid-19, la cual se encuentra en el siguiente Link https://www.youtube.com/watch?v=rS6HN01ZY8Y y trata sobre humanización de los servicios de salud en tiempos de pandemia del Covid-19, a cargo de la Dra. Carol Bernal, Fonoaudióloga, Magíster en Discapacidad e Inclusión Social, candidata a doctora Salud Pública y Secretaria General de la Asociación Colombiana de Salud Pública.

3. Gestión centrada en la persona

La gestión centrada en la persona constituye un enfoque fundamental en el sector salud, orientado a garantizar una atención integral que reconozca a cada individuo como un ser único, con necesidades, valores, expectativas y contextos propios. Este modelo trasciende la visión tradicional centrada exclusivamente en la enfermedad, para situar a la persona como eje del proceso de atención, promoviendo el respeto por su dignidad, autonomía y participación activa en la toma de decisiones. Desde esta perspectiva, la gestión en salud articula aspectos clínicos, organizacionales y relacionales, fortaleciendo prácticas humanizadas que integran el saber técnico con las dimensiones emocionales, sociales y culturales, contribuyendo así a mejorar la calidad del cuidado y la experiencia de las personas y sus redes de apoyo.

3.1. Antecedentes del modelo de atención centrada en la persona

En el desarrollo del presente apartado se toman los aportes de autores destacados, con el propósito de recordar las contribuciones que han influido de manera significativa en el modelo de atención centrada en la persona y en su aplicación actual como expresión de la humanización en el sector salud y en la atención en salud.

Por lo tanto, es importante mencionar que han transcurrido más de 60 años desde que Carl Rogers (1902–1987) propuso la terapia centrada en la persona (1951); sin embargo, sus investigaciones y planteamientos continúan siendo vigentes. Este enfoque considera a la persona en su totalidad y resalta la influencia de los aspectos somáticos y psicológicos en la salud. Inicialmente, Rogers denominó este modelo como terapia centrada en el cliente, argumentando que quien solicita apoyo profesional se sitúa en una relación de servicio; posteriormente, el término evolucionó hacia “persona”, con el fin de resaltar una mirada holística e integral del ser humano.

- **La persona como centro**

La terapia centrada en la persona, considera que los seres humanos son incondicionalmente válidos, independientemente de su comportamiento, condición o sentimientos.

En un contexto en que la persona se considere valorada, abandona las actitudes defensivas y gradualmente se vuelve capaz de escucharse a sí mismo y se abre a sentimientos de coraje, ternura y fervor. Para el autor "la persona es lo que es, en profundidad, es una experiencia enriquecedora".

Los siguientes se consideran procesos esenciales, basados en la perspectiva rogeriana:

- **Estimación positiva incondicional**

Implica aceptar y valorar a la persona en su totalidad, sin juicios ni condiciones, reconociendo su dignidad y valor intrínseco. En el contexto de la atención en salud, este proceso permite que el paciente se sienta respetado y comprendido, lo que reduce actitudes defensivas y favorece un clima de confianza.

- **Empatía**

Consiste en comprender profundamente el mundo interno de la persona, percibiendo sus emociones, pensamientos y significados como si fueran propios, sin perder la condición de profesional. En la atención en salud, esta capacidad permite interpretar adecuadamente las vivencias del paciente frente a la enfermedad y el tratamiento, promoviendo una comunicación más cercana y efectiva.

- **Congruencia**

Una persona que encuentra la congruencia entre su “yo ideal” y su “yo real” es menos propensa a vivenciar desequilibrios sicológicos. Por ello el terapeuta debería propiciar experiencias que permitan que el paciente estructure mejores visiones de sí mismo y su salud.

Rogers considera que un terapeuta necesita ser auténtico y entregarse por completo a la relación profesional del paciente, para lograr mayor efectividad.

- **Rol activo del paciente**

Este contexto le permite al paciente explorar su propia forma de ser y su complejidad, quien dentro de un contexto de atención en salud, conoce mejor sus problemas, lo que le lastima y lo que le ayudaría a solucionar.

Los principales cambios observados por Rogers en los pacientes, durante o después del final del proceso de terapia son:

- Se obtiene una nueva perspectiva sobre la libertad y el determinismo.
- Usa la creatividad como elemento de la vida plena.
- Pueden vivir en cualquier momento y cultura.
- Comienzan a vivir de manera constructiva; es decir, siempre continúan progresando para ser ellos mismos.
- Comportarse lo más completamente posible para satisfacer sus necesidades.

- **Modelo biopsicosocial**

Georges Engel, reconocido como el creador del modelo biopsicosocial, propone un enfoque que comprende a la persona como un ser integral, en el cual la dimensión psicológica constituye un componente esencial en la experiencia de la enfermedad. Este modelo destaca la importancia del contexto emocional y social en el que vive la persona, reconociendo que los factores psicológicos influyen en los procesos biológicos y que estos, a su vez, impactan el sistema social del paciente. El modelo biopsicosocial enfatiza una visión amplia e integrada de la salud, la enfermedad y la atención, con el propósito de evidenciar la interrelación entre las creencias familiares y la forma en que las personas y sus familias se adaptan a los procesos de enfermedad.

Basado en Borrell-Carrió (2002), sus fundamentos son:

- Una alteración bioquímica no siempre se traduce en enfermedad. Esta aparece por la interrelación de diversas causas, no solo moleculares, sino también psicológicas y sociales. A la inversa: de alteraciones psicosociales pueden derivarse enfermedades o «dolencias» que constituyen problemas de salud, incluso a veces con correlación bioquímica.
- La simple anomalía biológica no arroja ninguna luz sobre el significado de los síntomas para el paciente, ni asegura tampoco las actitudes y habilidades del clínico para recoger la información y procesarla de manera adecuada.
- Las variables de índole psicosocial suelen ser importantes a la hora de determinar la susceptibilidad, gravedad y curso del padecimiento más biológico que pudiera considerarse.

- La aceptación del rol de enfermo no viene determinada de manera mecánica por la presencia de una anomalía biológica.
- El tratamiento biológico puede tener diversas tasas de éxito influido directamente por variables psicosociales, tal como deja patente el llamado efecto placebo, entre otros.
- Además, la relación del profesional de la salud con el paciente, también interviene en el resultado terapéutico, aunque solo sea por la influencia que pueda tener sobre el cumplimiento del tratamiento.

Igualmente, existen los siguientes aspectos favorables de la perspectiva (biopsicosocial):

- Estimula a un conocimiento más integral del paciente y su entorno.
- Integra los hallazgos en las tres esferas: biológica, psicológica y social.
- Reconoce el papel central que desempeña la relación terapéutica en el curso de los acontecimientos.
- Optimiza el trabajo en equipo.
- Incorpora al profesional de salud como una pieza más del sistema que también debe ser cuidada.

- **Características**

Este modelo comienza a fundamentarse con las teorías de terapias familiares y luego son orientadas a entender los aspectos biopsicosociales que presenta el individuo cuando la atención médica está centrada en la familia, creando la terapia médica familiar. Por ello, se caracteriza principalmente por:

- **Integración cuerpo–mente**

Reconoce la interacción permanente entre los procesos físicos y psicológicos del individuo, comprendiendo que ambos influyen de manera conjunta en la salud, la enfermedad y el bienestar.

- **Influencia de la dinámica familiar en la salud**

Analiza cómo las relaciones familiares, las pautas de convivencia y los estilos de vida influyen en la adopción y mantenimiento de hábitos saludables.

- **Relación persona–familia–entorno social**

Considera la interdependencia entre la salud individual, el bienestar familiar, la relación terapéutica entre el profesional y el paciente, y el contexto social en el que se desarrolla la atención.

- **Atención centrada en la familia y comunicación**

Orienta la atención sanitaria hacia la participación activa de la familia, fortaleciendo la comunicación y el acompañamiento profesional mediante procesos de asesoramiento colaborativo.

- **Apoyo emocional y cuidado en el contexto familiar**

Promueve intervenciones ajustadas a las necesidades emocionales y de salud de las personas, reconociendo a la familia como un espacio fundamental de apoyo y contención.

- **La familia como sistema promotor de salud**

Concibe a la familia como un sistema interrelacionado que participa de manera conjunta en la construcción de hábitos saludables, como estrategia clave para la promoción de la salud.

El modelo biopsicosocial en evolución

Para profundizar en la reflexión de las relaciones de los anteriores modelos, se recomienda acceder al siguiente documento **Anexo_1_El_modelo_biosicosocial** el cual se encuentra disponible en la carpeta de Anexos. Este documento detalla con mayor profundidad esta temática.

3.2. Modelo de atención centrada en la persona

La perspectiva mostrada desde el modelo biopsicosocial o la terapia centrada en la persona, establece puntos de discusión que muestran la necesidad de incorporar al paciente como ser humano y a sus cercanos, familiares o agentes de cuidado, como seres activos, partícipes y agentes influyentes en el proceso de salud.

"Dar la palabra al paciente, dejarle participar en las decisiones, averiguar las expectativas que tiene, mostrar el profesional como ser humano, son puntos capitales del modelo". (Borrell-Carrió, 2002)

El modelo centrado en la persona constituye una estrategia fundamental de gestión para la humanización en salud. Si bien existen diversas interpretaciones sobre este enfoque, una de las principales reconoce que la humanización rescata lo más genuino y natural del ser humano, valorando a cada persona desde sus capacidades y promoviendo el fortalecimiento de habilidades propias del talento humano en salud.

Centrarse en la persona implica fortalecer de manera cotidiana la misión humana del cuidado, el espíritu de servicio y los valores personales, así como reorganizar o construir modelos de atención que orienten sus esfuerzos hacia las necesidades reales de las personas y de su red de apoyo.

A continuación, se presentan diversas formas de abordar la gestión de la humanización, a partir de experiencias y estrategias desarrolladas por organizaciones nacionales e internacionales en el ámbito de la atención en salud:

- **Modelo OMS**

La Organización Mundial de la Salud (OMS), plantea el siguiente modelo de atención centrada en la persona, teniendo en cuenta las necesidades integrales de las personas y las comunidades como el centro del sistema de salud, no solamente desde la enfermedad. Además, propone capacitar a las personas para que tengan un papel más activo en su propia salud:

Figura 1. Modelo OMS

- **Situación del país y nivel de desarrollo**
    - **Sector salud**: gobernanza, financiación y recursos.
    - **Prestación de servicios**: redes, recursos y profesionales.
    - **Otros sectores**: educación, sanidad, asistencia social, trabajo, vivienda, entorno y otros.
- **Persona**
- **Familia**
- **Comunidad**
- **Servicios sociales y sanitarios integrales centrados en las personas**

Asimismo, la OMS propone 5 objetivos estratégicos que son interdependientes para que la administración, aseguramiento, financiación, gestión, suministro, prestación, servicios y atención en salud se pueda centrar e integrar en las personas:

- **Empoderar y comprometer a las personas**

Hace referencia a involucrar, capacitar y proporcionar las oportunidades y recursos necesarios para que las personas participen activamente como usuarias de los servicios de salud. Este enfoque también busca llegar a los grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad, con el fin de garantizar el acceso universal a los servicios. Su objetivo es fortalecer la capacidad de las personas para tomar decisiones informadas sobre su propia salud y promover la participación de las comunidades en la coproducción de entornos saludables, la prestación de servicios en articulación con el sector salud y otros sectores, así como en la formulación de políticas públicas.

- **Fortalecimiento de la gobernanza y la rendición de cuentas**

Este proceso implica mejorar el diálogo en torno a las políticas públicas, así como la formulación, implementación y evaluación de estas, en conjunto con ciudadanos, comunidades y otras partes interesadas. Busca promover la transparencia en la toma de decisiones y consolidar sistemas sólidos de rendición de cuentas para responsables políticos, directivos, prestadores de servicios y usuarios del sistema de salud.

- **Reorientar el modelo de atención**

Se refiere al aseguramiento de la compra y la prestación de servicios de salud eficientes y efectivos, mediante modelos de atención que prioricen la atención primaria, comunitaria y la coproducción de la salud. Este proceso incluye el tránsito de un enfoque centrado en la atención hospitalaria hacia modelos ambulatorios e integrales, más cercanos a las necesidades de las personas y las comunidades.

- **Coordinación de servicios**

Hace referencia a la organización y articulación de la atención en torno a las necesidades y preferencias de las personas en todos los niveles del sistema de salud. Asimismo, promueve la integración de los distintos prestadores y la creación de redes efectivas entre el sector salud y otros sectores, mediante la alineación y armonización de procesos que mejoren la continuidad y calidad de la atención.

- **Crear un entorno propicio**

Para que las estrategias anteriores se consoliden como una realidad operativa, es necesario crear un entorno que facilite la participación y articulación de los diferentes actores involucrados. Este proceso implica transformaciones en los marcos normativos,

los mecanismos de financiación, los incentivos institucionales, la organización de la fuerza laboral y la formulación de políticas públicas que respalden un cambio sostenible en la atención en salud.

- **Perspectiva OES**

Según la Organización para la Excelencia en Salud (OES) refiere que, para garantizar la mejor atención al paciente se debe contar:

  - **Atención centrada en el paciente y su familia**

Necesariamente, la atención debe centrarse en el paciente y su familia como eje fundamental y conceptual del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad (SOGC).

  - **Participación activa en la toma de decisiones**

Es imperativo involucrar al paciente y a su familia en todo el proceso de atención, especialmente en la toma de decisiones relacionadas con el cuidado y el manejo de la enfermedad.

- **Modelo Organización Planetree**

Según la Organización Planetree International, plantea que la atención centrada en la persona es más que hospitalidad, ambiente saludable y confort, el cual crea impresiones positivas y experiencias satisfactorias en favor de la calidad de vida.

El modelo contribuye a la implementación sistemática de la humanización en la atención centrada en la persona y su familia, la cual se aborda de la siguiente manera:

- **Orientación del liderazgo**

Promueve líderes capaces de inspirar y establecer vínculos efectivos con el personal, facilitando la apropiación del enfoque y su integración como parte del abordaje estratégico de las organizaciones.

- **Planetree para el personal**

Se centra en el cuidado y reconocimiento de las personas que contribuyen al bienestar y la salud, valorando sus logros, buenas prácticas y el impacto positivo de su labor en el fortalecimiento de la atención centrada en la persona.

- **Evaluación cultural**

Implica la aplicación de encuestas de cultura organizacional que permitan identificar creencias, prácticas y acciones con impacto positivo, con el fin de construir planes de mejora inclusivos y colectivos, con la participación del personal administrativo y asistencial, así como de las personas y sus familias.

- **Desarrollo de programas**

Consiste en el diseño e implementación de programas prioritarios y preferenciales que resulten significativos y atractivos para las personas, fortaleciendo su experiencia en los servicios de salud.

- **Implementación de prácticas adecuadas para pacientes**

Hace referencia a la planificación, dirección y gestión de procesos orientados a implementar y fortalecer programas centrados en el cuidado de las personas.

- **Entrenamiento gerencial**

Se orienta a identificar las necesidades de coaching de gerentes y directivos, así como a desarrollar nuevas estrategias de motivación, involucramiento y capacitación del personal, definiendo roles claros dentro de una nueva estructura operativa.

- **Habilidades y estructuras**

Se enfoca en la identificación y fortalecimiento de las habilidades y estructuras necesarias, incluyendo la gobernanza, la toma de decisiones compartidas, el entrenamiento en interacciones empáticas, el desarrollo de equipos de salud y la expansión de contenidos de educación e investigación.

Con lo anterior, la atención centrada en la persona, crea ambientes saludables en el trabajo, mejora los resultados de salud y compromete a las comunidades en torno a la salud y el bienestar: asimismo, tiene efecto en el desempeño directo de las organizaciones de salud y mejora la experiencia de la persona, es decir cada integrante se siente valorado y con ello la institución se consolida.

Las siguientes son las contribuciones del modelo:

- Mejora el estado de salud de forma más rápida.
- Aumenta el nivel de excelencia de la calidad de la atención.
- Incrementa la fidelidad en la organización por parte de la persona, familia y comunidad.
- Aumenta el clima organizacional, fortaleciendo la satisfacción, liderazgo y compromiso del personal de salud; asimismo, en la satisfacción del sujeto de cuidado, su red de apoyo y comunidad.

- La eficacia en el uso de los recursos que dispone las organizaciones de salud, mejora el flujo de ingresos y su funcionamiento.
- Impulsa el mejoramiento continuo de la calidad de la atención.
- Brinda cercanía y conexión de la comunidad con la organización.

Modelo Planetree

El video que se encuentra en el siguiente Link https://www.youtube.com/watch?v=9DImhwsbHw4&t=40s presenta la ponencia de la directora de Planetree internacional, quien expone de manera clara su modelo.

3.3. Experiencias den Colombia

Las habilidades para la vida se desarrollan y manifiestan en diversos escenarios: político, organizacional, social, económico, cultural, ético y tecnológico y, en el ámbito institucional, se formalizan a través de lineamientos gerenciales, como las políticas de humanización que fortalecen la cultura organizacional. En este contexto, a continuación, se presentan experiencias desarrolladas en Colombia, en las que convergen estas características y se traducen en estrategias orientadas a la implementación de modelos de atención humanizada, centrados en la persona y en el reconocimiento de la dignidad humana:

- **Programa de humanización ESE - La Mesa**

Se presenta el programa de humanización en una Empresa Social del Estado (ESE) ubicada en La Mesa (Cundinamarca), que conforma estrategias, esfuerzos, actividades y proyecciones de atención centrada en la persona.

Video 3. Programa de humanización V6

Enlace de reproducción del video

Síntesis del video: Programa de humanización V6
Estamos convencidos de que un programa de humanización es funcional y efectivo solo si la gerencia se involucra en cada una de las etapas de los procesos. La integración de las diferentes áreas resulta indispensable al hablar de efectividad. Cualquier intento que se realice sin el apoyo mencionado impide el cumplimiento de los objetivos de humanización. La política de humanización cuenta con palabras clave que se hacen efectivas en la prestación de los servicios: desarrollo de competencias y valores, servicio con calidad, trato digno, seguro y confiable, respeto por la privacidad del usuario y

reconocimiento de dolencias. En esta institución excluimos todo tipo de maltrato, discriminación, agresión e indiferencia.

¿Y cómo se elaboró esta propuesta? Participamos en el nodo del Ministerio de Salud y Protección Social. Tuvimos el apoyo y asesoría tanto de Misión Salud como de la Oficina de Participación Social de la Dirección de Desarrollo de Servicios de la Gobernación de Cundinamarca. Articulamos la propuesta con la misión institucional, la cual hace parte fundamental de esta iniciativa e indica que la E.S.E. presta servicios de salud humanizados, seguros y con base en el mejoramiento continuo de los procesos.

Nuestra visión indica que para el año 2020 seremos una institución humanizada y segura en el departamento de Cundinamarca, reconocida por la prestación de servicios de salud con calidad.

El programa de humanización tiene tres ejes. El primero es el de usuarios; ellos son nuestra razón de ser. El segundo es el de servidores, entendidos como quienes ofrecen el servicio. Y el tercero es el de directivos; son ellos quienes guían y verifican el cumplimiento del programa.

Nuestros ejes cuentan con estrategias. La primera de ellas corresponde al eje usuarios, denominada “Ofreciendo luz en momentos de angustia”. Esta estrategia se hace efectiva cuando el personal asistencial informa que el paciente es diagnosticado con una enfermedad terminal, crónica o que amerita cuidados paliativos. En este momento se activa la ruta Código Lila, la cual consiste en proporcionar una habitación unipersonal y distinguirla: si es adulto, con una mariposa; si corresponde a un menor o neonato, con una paloma.

La segunda estrategia del mismo eje se denomina “Responsabilidad social: campañas altruistas”. Esta consiste en suplir necesidades básicas de pacientes que se encuentran en condición de vulnerabilidad económica o en abandono. Se activa la ruta mediante la detección y reporte del caso por parte del área asistencial o de vigilancia y, en articulación con el voluntariado nacional de Damas Rosadas, se ofrecen kits de aseo, pañales, sillas de ruedas, muletas, ropa, entre otros artículos.

Estrategia número tres: “Celebrando con nuestros usuarios”. Esta consiste en identificar algunas fechas especiales en el año y, en articulación con los servidores y la asociación de usuarios, desarrollar actividades de esparcimiento que permiten la integración entre clientes internos, pacientes y sus familias en un escenario diferente.

La cuarta estrategia, “Mejorando andamos”, permite ofrecer actividades de manejo del tiempo libre dentro de la institución. En los servicios, el personal asistencial promociona pasatiempos como sopas de letras, laberintos o lecturas de libros. Contamos con una biblioteca hospitalaria que tiene derivaciones en diferentes servicios para el fácil acceso de todos. El hospital ha realizado un enorme esfuerzo para ofrecer a los acompañantes que se encuentran en los diferentes servicios una zona cálida denominada “Literatura Café”.

La quinta y última estrategia de este eje, “Sembrando amor, cosechando vida”, cuenta con un equipo altamente capacitado y con la ruta materna y paterna. Además, trabajamos para que el proceso de gestación, el trabajo de parto y el nacimiento se conviertan en una experiencia positiva para las pacientes y, por supuesto, para sus familias.

Ahora pasemos al eje número dos: servidores, el cual cuenta con dos estrategias. La primera de ellas, “Capacitando a nuestros servidores”. El programa de inducción tiene como eje central la humanización. Quien ingresa a la institución se conecta inmediatamente con nuestra política y con el claro objetivo de ofrecer el mejor trato al paciente.

La segunda estrategia, “Fomentando el uso del carné y el saludo institucional”. En el AC Plan nos caracterizamos por saludar, sonreír e identificarnos con el paciente. Esto genera una relación más cercana entre el servidor y el usuario.

Y, por último, el eje que ha hecho posible la existencia y adherencia del programa de humanización: el de directivos. Este cuenta con una estrategia denominada “El gerente con la gente”. Ella permite que la humanización pase de ser un simple atributo, producto o servicio adicional y se convierta en el imperativo ético de los servicios.

Lo que hemos considerado es que la humanización, desde que llegamos aquí, es fundamental para nosotros. Sin embargo, sabemos que la organización es un todo y que toda la comunidad debe tener conciencia de lo que esto significa. Adicional a ello, también es una necesidad que nuestros socios tengan los recursos necesarios para que puedan realizar su labor. Consideramos que esto no es algo adicional; el ser humano en acción, para mí, es el respeto: respeto por mi compañero, el trato con él. Es el don de gentes que queremos tener desde la gerencia administrativa.

Fortalecemos los procesos de humanización y nos acogimos totalmente a este programa, desarrollando actividades de fortalecimiento de la infraestructura y

generando escenarios adecuados para que los usuarios de nuestra entidad se sientan cómodos y en un medio ambiente adecuado.

Desde el momento en que el funcionario o la persona llega a ser parte de nuestro hospital, activamos y hacemos mucho énfasis en nuestra política de humanización en la capacitación, y la establecemos como una de las políticas más importantes que tiene el hospital. Incluso manejamos un video institucional donde se enfocan las políticas del hospital y una de las más importantes es la humanización.

Desde la subdirección médica adelantamos varias labores que repercuten, de manera directa o indirecta, en el trato humanizado de los pacientes. Algunas de ellas incluyen, por ejemplo, la revisión de casos clínicos, no solamente con el enfoque asistencial de pertinencia, sino también con el enfoque actitudinal que pudo haber tenido el profesional de la salud en el marco de esa atención. A partir de los resultados que obtenemos y de las conclusiones preliminares, invitamos al profesional a discutir el caso y tomamos determinaciones como planes de mejora, los cuales son objeto de seguimiento.

Como organización brindamos todo el apoyo y asesoría a la referente en la documentación del programa y en cómo establecerlo, aportando nuestros puntos de vista y experiencias en las reuniones que realizamos.

Tenemos una ruta de manera integral donde, desde el instante en que la paciente tiene su cita o se entera de que está en nuestra institución, se le brinda la oportunidad de llevar su control prenatal de la manera más humanizada e integral. El trato es saludar a la paciente educadamente, llamarla por su nombre y explicarle el

procedimiento, cuánto puede durar y resolver sus inquietudes, generando confianza entre el paciente y el profesional.

Desde admisiones y referencia hemos creado estrategias para que el cliente siempre esté en contacto con la institución y poder dar solución a todos los casos, priorizando los que tienen mayor urgencia y brindando tranquilidad a los familiares.

También inculcamos en los auxiliares la importancia del saludo, la atención prioritaria y el adecuado manejo en la toma de muestras. Trabajamos con los servicios en capacitaciones de humanización en salud, tanto para los usuarios como para nuestros funcionarios.

Contamos con el programa del Código Lila, que ayuda a los pacientes que tienen una enfermedad terminal; se les brinda información adecuada y una habitación especial para que, cuando reciban visita, no tengan ningún inconveniente.

Desde atención al usuario prestamos un servicio humanizado, brindamos la bienvenida y generamos acompañamiento desde el ingreso. Explicamos el proceso de atención preferencial de los pacientes e informamos todo el procedimiento en cuanto a peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, fundamentales frente a los planes de mejora que se generan.

Desde hace unos años el cambio ha sido excelente. Desde los buenos días, tanto de la señora de servicios generales como de algún médico, es algo excelente. Muy buena atención, buen trato, entre otras cosas. Precisamente durante los últimos años hemos avanzado demasiado.

El área es muy importante: los baños, las instalaciones, todo está ahora más organizado. Ese cambio ha sido significativo.

Por eso, el área de calidad y planeación nos indica que un programa que no se mide no es un programa efectivo. Es así como establecimos cuatro indicadores para nuestro programa. El primero tiene que ver con el cumplimiento del programa de humanización y está basado en el número de actividades propuestas frente al número de actividades desarrolladas.

Tenemos un segundo indicador con el cual pretendemos medir la adherencia al programa. Este tiene como instrumento base una lista de chequeo que se realiza servicio por servicio, bajo la observación de la prestación del servicio.

Como tercer indicador tenemos el número de PQRS, donde identificamos cómo han disminuido frente al semestre anterior. Podemos decir que, de 229 PQRS recibidas, tan solo el 15 % de ellas estuvieron relacionadas con humanización.

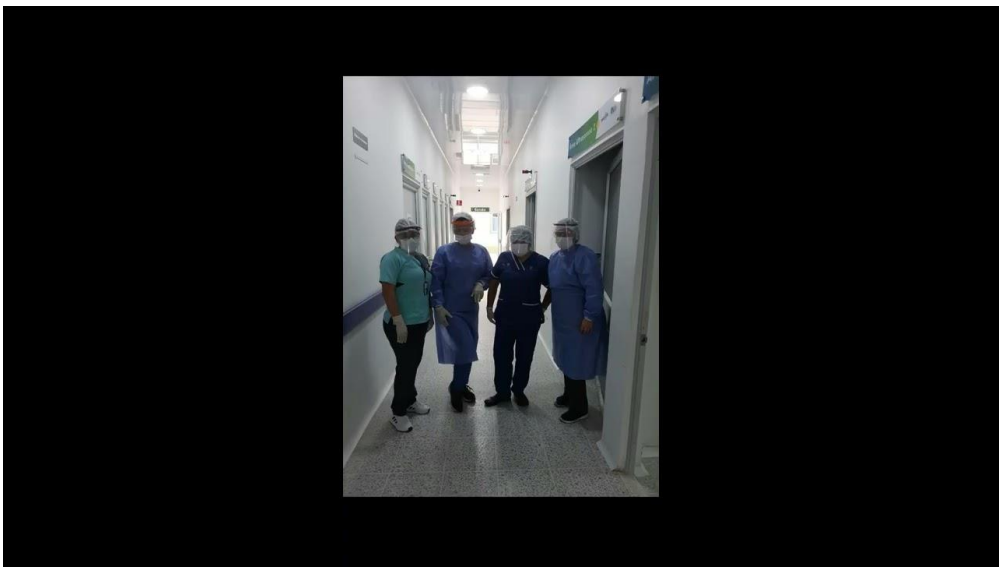
Y nuestro cuarto indicador es el plan de formación en humanización. Verificamos el número de colaboradores o servidores de la institución que participan en la inducción, capacitación y relanzamiento del programa.

Nuestros indicadores no tuvieron un porcentaje del cien por ciento, pero sí porcentajes significativos que nos llevaron a consolidar la humanización en el Hospital Pedro León como un programa que supera el alcance del papel, un programa que realmente se vive.

- **Estrategia aplicada ESE- La Mesa**

Se presenta una de las estrategias utilizadas para abordar el programa de humanización en una en una Empresa Social del Estado ubicada en La Mesa (Cundinamarca). El apoyo emocional como eje de abordaje.

Video 4. Estrategia Apoyo Emocional - Trabajo Social



Enlace de reproducción del video

Síntesis del video: Estrategia Apoyo Emocional - Trabajo Social
En efecto, son héroes, pero también son humanos: necesitan apoyo, fortaleza y esperanza. El Hospital Pedro León garantiza el bienestar de sus trabajadores con el objetivo de que se encuentren preparados para atender la contingencia de la manera más humanizada y segura posible.

La estrategia de apoyo emocional, implementada desde el programa de humanización institucional, surge como iniciativa de la gerencia y de las subgerencias científicas, dando respuesta a la evidente crisis emocional detectada en los servidores a raíz de la pandemia y del cambio de estilo de vida por ella producido.

Todos estos elementos han generado una evidente disminución del estado de ánimo, así como incertidumbre, sentimientos de frustración y angustia, por lo que se hace necesario e indispensable fortalecer la salud mental de nuestros servidores a través de múltiples estrategias, entre ellas la sala de apoyo emocional.

¿Cómo se realiza la convocatoria y la selección del personal que asistirá?

La convocatoria se realiza a través de grupos de WhatsApp, mediante una lámina informativa instalada como protector de pantalla en todos los computadores de la institución. También se lleva a cabo de manera personalizada, teniendo en cuenta el nivel de estrés manifestado e identificado por los líderes de las diferentes áreas. Esto quiere decir que ellos priorizan e informan a Trabajo Social.

Adicionalmente, se coordinan brigadas que permiten atender en nuestros centros y puestos de salud al personal que allí labora, y se ofreció el servicio a las personas de las alcaldías que se encuentran relacionadas con actividades en el marco de la emergencia por COVID-19.

En esta convocatoria descrita se informan las fechas y los horarios semanales disponibles para la atención. El día en que asisten los convocados, se ofrece el servicio en el hospital; el equipo de atención se ubica en el tercer piso y, en centros y puestos de salud, se adecua un espacio que cuente con las condiciones requeridas.

¿Y cómo funciona la estrategia?

Ingresan a la sala grupos de cinco personas y son atendidas a través de un circuito compuesto por cuatro zonas.

En la primera de ellas se ofrece aromaterapia natural mediante esencias, aceites y cremas naturales que la compañía Jobs, a través de su líder ejecutiva regional y médico, la doctora Clemencia Gómez, donó como apoyo al programa de humanización.

La segunda zona se denomina “Relajación y conciencia corporal”. En ella se promueve el equilibrio emocional a través de la respiración y la relajación muscular.

El paso por la tercera zona proporciona consejos básicos que permiten influir en nuestro entorno y controlar nuestras acciones en pro del autocuidado. Aquí hacemos énfasis en la alimentación saludable, la importancia del descanso, el sueño reparador, los pensamientos positivos y el adecuado manejo del tiempo libre. Adicionalmente, se invita al personal a visualizar su futuro de una manera positiva y a registrarlo en un mural.

Como cuarta y última zona se ofrece un espacio para catarsis y apoyo emocional, eliminación de miedos y fortalecimiento del estado de ánimo a través de la esperanza.

Como cierre de la actividad, se realiza una invitación a la transmisión de felicidad, seguridad y buen trato a nuestras familias y a todos nuestros pacientes.

- **Programa de humanización ESE Sesquilé**

Se presenta una de las estrategias utilizadas para abordar el programa de humanización en tiempos de COVID por una ESE de Sesquilé (Cundinamarca).

Video 5. Humanización Hospital Sesquilé

Enlace de reproducción del video

Síntesis del video: Humanización Hospital Sesquilé
La E.S.E. Hospital San Antonio de Sesquilé y el Puesto de Salud de Gachancipá, atendiendo el estado de emergencia de salubridad pública debido a la pandemia COVID-19, implementaron el programa de visitas domiciliarias al club de crónicos y gestantes durante el mes de abril y la primera semana de mayo del año 2020. Contamos con el equipo humano necesario: ocho médicos, cuatro enfermeras profesionales, diez auxiliares de enfermería y cuatro conductores.

Recorrimos 15 barrios, 18 veredas y más de 290 kilómetros.

Llegamos a 350 hogares, atendimos 537 pacientes y entregamos más de 2.100 medicamentos.

Dando cumplimiento a nuestra política de seguridad del paciente y, dada la contingencia de la pandemia por COVID-19, la E.S.E. Hospital San Antonio de Sesquilé y el Puesto de Salud de Gachancipá han venido fortaleciendo el correcto y constante lavado de manos, tanto en colaboradores como en usuarios de los municipios de Gachancipá y Sesquilé.

La E.S.E. Hospital San Antonio de Sesquilé realiza capacitaciones en lavado de manos y uso de elementos de protección personal a dueños de negocios, comerciantes y conductores de servicio público de los municipios de Sesquilé y Gachancipá.

Del 29 de abril al 1.º de mayo recorrimos los sectores rurales de los municipios de Sesquilé y Gachancipá, logrando vacunar a más de 340 personas entre adultos mayores, menores de 5 años y gestantes. Se visitaron 15 veredas, más de 250 hogares y cerca de 310 kilómetros fueron recorridos, con un centenar de vacunas aplicadas por día.

Desarrollamos pausas activas que pretenden minimizar el riesgo en la ejecución de actividades del equipo humano que labora en el Hospital San Antonio de Sesquilé y en el Puesto de Salud de Gachancipá.

Realizamos jornadas que permiten lograr la prevención del riesgo psicosocial en el equipo humano, tanto asistencial como administrativo, de la E.S.E. Trabajamos

en la articulación entre las áreas de humanización, seguridad y salud en el trabajo, gestión ambiental y seguridad del paciente.

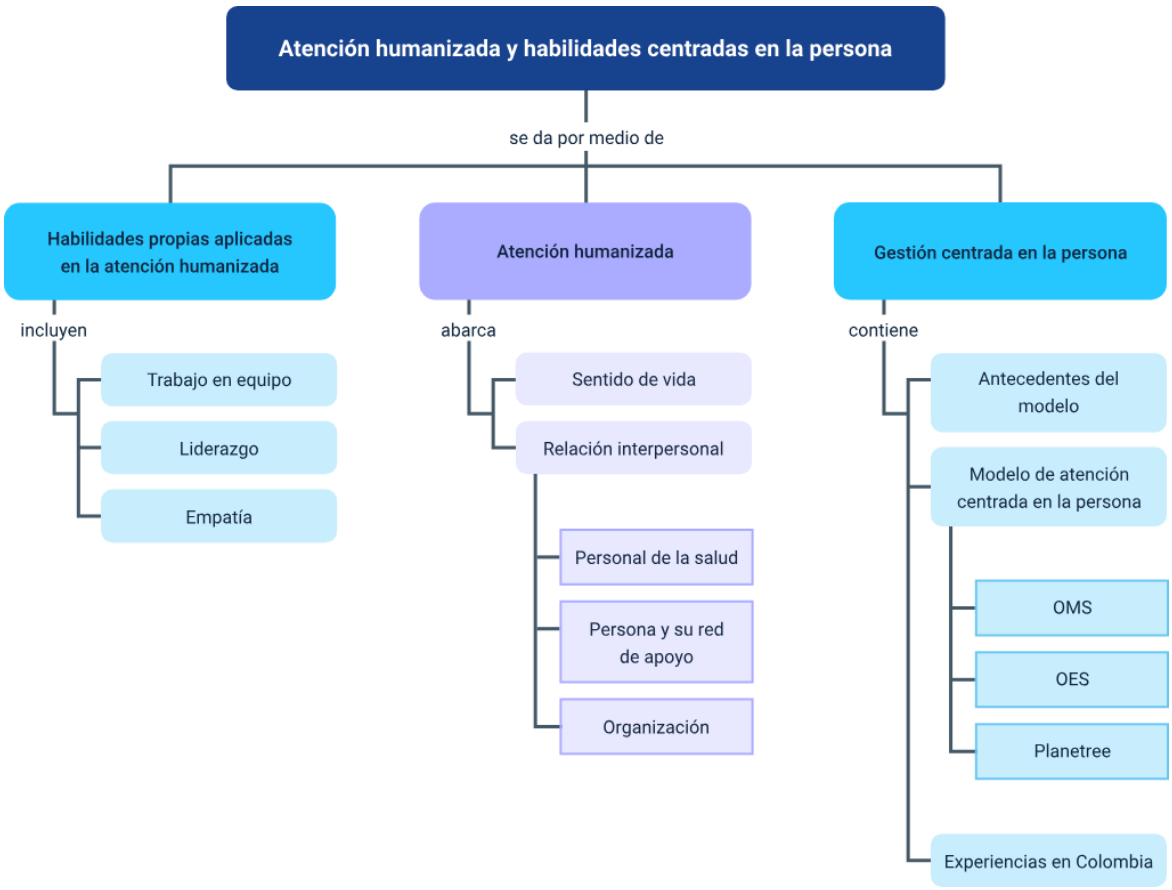
Este proceso es liderado por la gerencia de la E.S.E. Hospital San Antonio de Sesquilé y el Puesto de Salud de Gachancipá.

Se agradece a la Secretaría de Salud de Cundinamarca, a la EPS Convida y al apoyo de la Alcaldía Municipal de Gachancipá y la Alcaldía Municipal de Sesquilé.

Yo me quedo en casa.

Síntesis

Este componente formativo aborda la atención humanizada desde el fortalecimiento de las habilidades propias del talento humano en salud. A partir de la comprensión de la atención humanizada, se reflexiona sobre el sentido de vida y la importancia de las relaciones interpersonales que se establecen entre el personal de la salud, la persona atendida, su red de apoyo y la organización, reconociendo su impacto en la calidad del cuidado. Asimismo, se profundiza en la gestión centrada en la persona mediante el análisis de los antecedentes y fundamentos del modelo de atención centrada en la persona, su aplicación práctica y las experiencias desarrolladas en Colombia, promoviendo una atención integral que respete la dignidad, la autonomía y las necesidades individuales en los distintos contextos de salud.



Glosario

Atención centrada en las personas: es un enfoque de atención que adopta conscientemente a individuos, cuidadores, familias y comunidades, desde la mirada de participantes y beneficiarios del sistema de salud, que responden a sus necesidades y preferencias de manera humana y holística. La atención centrada en las personas también requiere que las personas tengan la educación y el apoyo que necesitan para tomar decisiones y participar en su propio cuidado. Se organiza en torno a las necesidades de salud y expectativas de las personas en lugar de enfermedades, enfoques y prácticas de atención que ven a la persona como un todo con muchos niveles de necesidades y objetivos, con estas necesidades provenientes de sus propios determinantes sociales personales de la salud. (WHO, 2015).

Atención continua: se brinda a las personas a lo largo del tiempo a lo largo de su vida. (WHO, 2015).

Atención de alta calidad: atención segura, efectiva, centrada en las personas, oportuna, eficiente, equitativa e integrada. (WHO. 2015).

Compromiso: involucrar a las personas y las comunidades en el diseño, la planificación y la prestación de servicios de salud, por ejemplo, permítanos tomar decisiones sobre la atención y las opciones de tratamiento o participar en la toma de decisiones estratégicas sobre cómo se gastan los recursos de salud. (WHO. 2015).

Empoderamiento: el proceso de apoyar a las personas y las comunidades para que tomen el control de sus propias necesidades y resultados de salud; por ejemplo, en

la adopción de comportamientos más saludables o la capacidad de autocontrol de enfermedades. (WHO. 2015).

Habilidades sociales: este componente hace referencia a la capacidad de las personas para manejar las relaciones con los demás y conducirlos hacia la dirección que se desee.

Interdisciplinario: actividad que se realiza en cooperación de varias disciplinas.

Multidisciplinario: actividad que abarca o afecta a varias disciplinas. No necesariamente en cooperación.

Referencias bibliográficas

Borrell-Carrió, F. (2002). El modelo biopsicosocial en evolución. Medicina Clínica, 119, pp. 175–179.

Borrell-Carrió, F. (2004). Entrevista clínica: habilidades de comunicación para profesionales de la salud. Barcelona: Elsevier España.

Goleman, D. (1995). Inteligencia Emocional. Por qué es más importante que el cociente intelectual. Barcelona, España. Ediciones B, S.A.

Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación. (2000). Trabajo en Equipo, Módulo 09. Competencias para la profesionalización de la gestión educativa: diez módulos destinados a los responsables de los procesos de transformación educativa. pp. 6-9.

Organización para la Excelencia de la Salud. (2017, 9 de junio). Atención Centrada en la Persona - Susan Frampton | Planetree. [Video] YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=9DImhwsbHw4&t=40s

Phono critical care. (2020, 30 de agosto). Humanización de los servicios de salud en tiempos de Covid-19. [Video] YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=rS6HN01ZY8Y

Rogers, C. R. (1951). Client-centered therapy: Its current practice, implications, and theory. Boston: Houghton Mifflin.

The Health Foundation. (2015, 2 de febrero). Person-centred care made simple. [Video] YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=6Dk3CV-Wt38

Toro Suarez L. Y. (2015). La importancia del trabajo en equipo en las organizaciones. Universidad Militar Nueva Granada.

World Health Organization (WHO). (2015). Global Strategy on People Centered and Integrated Health Services. Interim report.

World Health Organization (WHO). 2015 Global Strategy on People Centered and Integrated Health Services 2016-2026. Executive Summary, Placing people and communities at the centre of health services.

World Health Organization (WHO). (2017, 21 de julio). WHO: What is people-centred care? [Video] YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=pj-AvTOdk2Q

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Claudia Johanna Gómez Pérez	Responsable Ecosistema de Recursos Educativos Digitales (RED)	Dirección General
Diana Rocío Possos Beltrán	Responsable de línea de producción	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
John Edward Cruz	Experto temático	Ministerio de Salud - Oficina de calidad
Rafael Neftalí Lizcano Reyes	Asesor pedagógico	Centro Industrial del Diseño y la Manufactura - Regional Santander
Andrés Felipe Velandia Espitia	Evaluador instruccional	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Oscar Ivan Uribe Ortiz	Diseñador de contenidos digitales	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
José Jaime Luis Tang Pinzón	Diseñador de contenidos digitales	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Veimar Celis Meléndez	Desarrollador full stack	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Ernesto Navarro Jaimes	Animador y productor audiovisual	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
María Fernanda Pineda Mora	Evaluadora de contenidos inclusivos y accesibles	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Javier Mauricio Oviedo	Validador y vinculador de recursos educativos digitales	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima